

CAPÍTULO 14.24

Arteritis de Células Gigantes

PERFIL EUNACOM 1.14.24

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción

La **Arteritis de Células Gigantes (ACG)**, clásicamente conocida como **Arteritis de la Temporal**, es una vasculitis de vasos grandes y medianos que afecta predominantemente a las ramas de la carótida externa. Es la vasculitis primaria más frecuente en la población adulta, específicamente en pacientes **mayores de 50 años**. Es una patología de alta relevancia clínica debido a que representa una de las causas principales de **Síndrome Febril Prolongado** (fiebre de origen desconocido) en el adulto mayor y conlleva un riesgo inminente de ceguera irreversible si no se trata a tiempo.

Cuadro Clínico

La presentación de la ACG es muy variada y suele ser florida en el adulto mayor. Se puede dividir en síntomas sistémicos, musculoesqueléticos y vasculares específicos.

1. Síntomas Constitucionales (Inespecíficos)

Muchos pacientes debutan con un cuadro similar a los "síntomas B" de los linfomas: - **Astenia** y malestar general. - **Fiebre** (frecuentemente es una fiebre de origen desconocido). - **Baja de peso** involuntaria.

2. Polimialgia Reumática (PMR)

Existe una asociación muy estrecha entre la ACG y la **Polimialgia Reumática**. - Se presenta con **mialgias generalizadas** de predominio proximal (hombros y cadera). - **Rigidez matinal** marcada. - Aproximadamente el 50% de los pacientes con ACG tienen PMR, y un 15-20% de los pacientes con PMR desarrollarán ACG.

3. Manifestaciones Craneales y Faciales

Debido a la inflamación de las ramas de la carótida: - **Cefalea**: De inicio reciente, habitualmente localizada en la zona temporal. - **Hipersensibilidad del cuero cabelludo**: Dolor al peinarse o al tocar las arterias temporales (pueden palparse nodulares o sin pulso). - **Claudicación mandibular**: Dolor o cansancio en los músculos masticatorios (maseteros) al comer. Es un síntoma de alta especificidad para esta enfermedad.

4. Manifestaciones Oculares

Es la complicación más temida. - **Amaurosis fugax**: Pérdida transitoria de la visión en un ojo. - **Neuropatía Óptica Isquémica Anterior (NOIA)**: Pérdida de visión súbita y permanente por isquemia del nervio óptico.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La pérdida visual en la ACG suele ser irreversible. Ante la sospecha clínica de compromiso ocular, el tratamiento con corticoides debe iniciarse de forma **inmediata**, incluso antes de realizar la biopsia.

5. Complicaciones Neurológicas

La afectación de la carótida interna o sus ramas puede derivar en: - **Accidente Isquémico Transitorio (TIA)**. - **Accidente Cerebrovascular (ACV)** isquémico.

Laboratorio y Marcadores

A diferencia de otras vasculitis, la ACG **no posee anticuerpos específicos** (es ANCA negativa).

TABLA 14.24.1: PARÁMETRO VS HALLAZGO TÍPICO

PARÁMETRO	HALLAZGO TÍPICO	NOTAS
VHS (Velocidad de Sedimentación)	Muy elevada (>100 mm/h)	Es el marcador más característico, aunque inespecífico.
PCR (Proteína C Reactiva)	Elevada	Refleja la inflamación sistémica.
Hemograma	Fenómeno de Ruló	El apilamiento de eritrocitos se asocia a la VHS muy alta (similar al Mieloma Múltiple).
Anticuerpos (ANCA, ANA)	Negativos	No existen anticuerpos diagnósticos para ACG.

NOTA CLÍNICA

El **fenómeno de Ruló** (Rouleaux) ocurre cuando los niveles de proteínas de fase aguda (como el fibrinógeno) son tan altos que neutralizan las cargas negativas de los glóbulos rojos, permitiendo que se agrupen como "pilas de monedas".

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y se confirma mediante estudio histológico.

- **Sospecha Clínica**: Adulto mayor con cefalea nueva, VHS elevada y/o claudicación mandibular.
- **Biopsia de Arteria Temporal**: Es el **estándar de oro**. Se prefiere la arteria temporal superficial porque es accesible y su sección no deja secuelas funcionales, a diferencia de arterias intracraneales.
- **Hallazgos Histológicos**: Inflamación granulomatosa de la capa media, fragmentación de la elástica interna y presencia de **células gigantes** (aunque su ausencia no descarta el diagnóstico).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Debido a que la afectación de la arteria es "segmentaria" (saltatory conduction), la biopsia debe ser de un segmento largo (2-3 cm) para evitar falsos negativos por zonas sanas.

Tratamiento

El pilar fundamental del tratamiento son los **corticoides**, a los cuales la enfermedad suele responder de forma dramática y rápida.

- **Dosis estándar**: Prednisona oral a dosis altas (**1 mg/kg/día**).
- **Urgencia visual**: Si hay compromiso ocular activo, se suele iniciar con pulsos de metilprednisolona endovenosa antes de pasar a la vía oral.
- **Mantenimiento**: El descenso de la dosis de corticoides debe ser muy lento y guiado por la clínica y los niveles de VHS/PCR, habitualmente extendiéndose por 1 a 2 años.

EUNACOM CRITERIOS

Regla de oro EUNACOM: Nunca retrases el inicio de los corticoides por esperar el resultado o la realización de la biopsia si la sospecha clínica es alta, especialmente si hay riesgo visual. La biopsia sigue siendo útil incluso hasta 1-2 semanas después de iniciados los corticoides.

Resumen de Perlas EUNACOM

- **Perfil del paciente**: >50 años (generalmente >70). - **Clave diagnóstica**: Cefalea + VHS > 100 + Claudicación mandibular. -

Asociación: Polimialgia Reumática. - **Riesgo mayor:** Ceguera por NOIA. - **Tratamiento:** Prednisona 1 mg/kg/día.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Adulto mayor con cefalea, claudicación mandibular, dolor del cuero cabelludo y VHS de 110 mm/h. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Arteritis de Células Gigantes. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Vasculitis primaria más frecuente; se presenta en adultos mayores
- Causa de fiebre de origen desconocido en el adulto mayor
- Clínica: polimialgia reumática, cefalea, dolor del cuero cabelludo, claudicación mandibular, amaurosis fugax
- Neuropatía óptica isquémica: pérdida de visión definitiva (a diferencia de amaurosis fugax que es transitoria)
- VHS muy elevada es el marcador más orientador; ANCA negativa, sin anticuerpo específico
- Diagnóstico: biopsia de arteria temporal superficial
- Tratamiento: prednisona 1 mg/kg/día (corticoides en dosis altas)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES)

PREGUNTA 1

Adulto mayor con cefalea, claudicación mandibular, dolor del cuero cabelludo y VHS de 110 mm/h. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Arteritis de Takayasu
- B) Poliarteritis nodosa
- C) Arteritis de células gigantes
- D) Granulomatosis de Wegener
- E) Meningitis

PREGUNTA 2

¿Qué arteria se biopsia para confirmar el diagnóstico de arteritis de células gigantes?

- A) Arteria cerebral media
- B) Arteria carótida interna
- C) Arteria temporal superficial
- D) Arteria subclavia
- E) Arteria meníngea media

PREGUNTA 3

Paciente con arteritis de células gigantes presenta pérdida de visión en un ojo que no se recupera. ¿Cuál es el mecanismo?

- A) Amaurosis fugax
- B) Desprendimiento de retina
- C) Neuropatía óptica isquémica
- D) Glaucoma agudo
- E) Neuritis óptica desmielinizante

RESUMEN: ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES

La arteritis de células gigantes (arteritis de la temporal) es la vasculitis primaria más frecuente de todas. Se presenta en adultos mayores y es causa de fiebre de origen desconocido en esta población. La clínica es florida: síntomas inespecíficos (astenia, fiebre, malestar general, baja de peso), polimialgia reumática (mialgias proximales con rigidez matinal), cefalea, dolor al tocar el cuero cabelludo, claudicación mandibular, y síntomas oculares como amaurosis fugax (pérdida transitoria de visión) o neuropatía óptica isquémica (pérdida definitiva). Puede complicarse con AIT o ACV por afectación de carótida interna. Es ANCA negativa, sin anticuerpo específico asociado. Su marcador es la VHS muy elevada (asociada a fenómeno de Rouleaux). El diagnóstico se confirma con biopsia de arteria temporal superficial. El tratamiento es con corticoides vía oral en dosis altas (1 mg/kg/día de prednisona).